

УДК: 616-6

Р.К.Каракулов, С.Т.Габбасова, Г.А. Сагиндыков., Б.А.Насипов,
А.С.Джазылтаева, Б.М.Жумадуллаев

Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии

Применение Ритуксимаба при лечении больных с первичной Неходжкинской лимфомой желудочно-кишечного тракта

Аннотация. В работе приведены результаты лечения 16 больных с НХЛ желудочно-кишечного тракта III-IV A и B стадий, из них у 6 детей с НХЛ тонкого и толстого кишечника.

У 6 детей с НХЛ ЖКТ после проведенной резекции кишечника впервые использован таргетный препарат - Ритуксимаб, при В-клеточной форме НХЛ ЖКТ. Все пациенты получали 6 курсов ПХТ по режиму R-CHOP, пятилетняя выживаемость составила 100%.

У 10 взрослых больных с В-клеточной формой НХЛ ЖКТ использована схема R-CHOP, общая пятилетняя выживаемость составила 90%.

Ключевые слова: НХЛ желудочно-кишечного тракта, В-клеточная НХЛ, ритуксимаб, общая пятилетняя выживаемость.

За последние десятилетия отмечается значительный рост заболеваемости неходжкинскими лимфомами (НХЛ). Она выше в развитых странах, самая высокая заболеваемость (6,8-16,6‰) отмечается в США Канаде, Великобритании и Европе, а низкая (2,9-4,1‰) – в Ю.Америке, Китае, Индии, России и Казахстане [IARC]-2012]. В РК заболеваемость гемобластозами составляет 8,0 на 100 тыс., а смертность 4,4‰ [3,4,9].

Неходжкинские лимфомы представляет собой гетерогенную группу лимфопролиферативных заболеваний, различающихся по морфологическому строению, клинической картине, характеру и результатам проводимой терапии.

В настоящее время отмечается возрастание количества пациентов с экстранодальными НХЛ, которые наиболее часто поражают желудочно-кишечный тракт (ЖКТ). центральную нервную систему, ВИЧ-инфицированных пациентов [1,8]. При этом именно ЖКТ является наиболее распространенным проявлением злокачественных лимфом (40%), а его вовлечение в патологический процесс может происходить на любых этапах основного заболевания. Причем, среди первичных НХЛ ЖКТ наиболее часто поражается желудок (55-70%), реже тонкая кишка и илеоцекальная область (20-35%) и толстая кишка – 5-10%, а первичные НХЛ пищевода вообще описаны в единичных клинических наблюдениях.

В России лимфомы составляют 2,8% всех злокачественных опухолей, из которых на НХЛ желудочно-кишечного тракта приходится от 1 до 15% всех ЗН, локализующихся в данной анатомической области [5,10].

В Казахстане еще нет четкой статистики по заболеваемости злокачественных лимфом ЖКТ. Ежегодно в отделении гемобластозов получают около 10 больных с лимфомами ЖКТ.

Современная диагностика НХЛ ЖКТ предусматривает проведение таких клинико-диагностических мероприятий, эндоскопическая ультразвуковое исследование, биопсия, КТ, МРТ, ПЭТ-КТ.

Гистологический диагноз лимфомы ЖКТ верифицируется только при наличии четких морфологических признаков заболевания, а также при использовании методов ИГХ (определение CD45KB, CD 19, CD 20, CD 22, CD29a антигенов) и данных МГИ, структурные или регуляторные изменения генов BCL 1, BCL 2, BCL 10, с t(14;18) p16 [7,15,17]. Для подтверждения положения именно о наличии первичной лимфомы ЖКТ, помимо гистологического подтверждения диагноза еще используется, так называемые, критерий Доусона, которые включают в себя отсутствие пораженных периферических лимфоузлов во время постановки диагноза, отсутствие увеличенных лимфоузлов средостения, нормальные показатели периферической крови, возможно наличие во время лапаротомии видимого поражения кишечника и только регионарных лимфоузлов, а также отсутствие поражения печени и селезенки.

Подводя итоги анализа, имеющихся на сегодняшний день исследований, можно сделать вывод, что, начиная с 2000 г. (с момента внедрения в широкую клиническую практику ритуксимаба – моноклональных антител к CD20(+)) существенно улучшились результаты лечения В-клеточных индолентных и агрессивных лимфом у взрослых. Применение ритуксимаба как в индукции, так и в поддержке, на сегодняшний момент является едва ли не единственным способом добиться максимального эффекта терапии. Ритуксимаб обладает таргетным воздействием на злокачественные В-клетки, благодаря чему позволяя снизить токсичность режима химиотерапии без потери клинического эффекта за счет снижения доз химиопрепаратов.

Однако остается не решенная проблема, касающаяся комбинированной терапии экстранодальных лимфом, в частности лимфом ЖКТ.

Цель исследования – улучшение отдаленных результатов лечения больных с лимфомой желудочно-кишечного тракта у взрослых и детей.

Материал и методы. Материалом исследования служили результаты лечения 16 больных, 10 взрослых пациентов и 6 детей с первичной НХЛ желудочно-кишечного тракта III-IV A и B стадий, наблюдавшихся в отделении гемобластозов с 2005 по 2014гг.

Дизайн исследования: – впервые проведено изучение эффективности нового режима ПХТ (R-CHOP 21) с первичной НХЛ ЖКТ у детей: (ритуксимаб по 375 мг/м², циклофосфамид 750 мг/м², доксорубин 50 мг/м², вин-

кристин 1,4 мг/м², все в 1 день, преднизолон 60 мг/м² с 1-5 дни с учетом фенотипических особенностей, генетических маркеров (1 основная группа).

Вторая основная группа включила больных с первичной формой НХЛ ЖКТ, получавшие лечение по схеме R-CHOEP-21 (ритуксимаб по 375 мг/м², циклофосфамид 750 мг/м², доксорубин 50 мг/м², винкристин 1,4 мг/м², все в 1 день, этопозид по 100 мг в/в 3-5 дни), преднизолон 60 мг/м² с 1-5 дни).

Исследование будет проводиться в соответствии с протоколом, ориентированными на выполнение правилами GCP и нормативными требованиями.

Основной конечный результат – изучение непосредственной эффективности лечения и общей 5-летней продолжительности жизни больных с НХЛ III-IVA и V стадий в основной и контрольной группах.

Первичные конечные точки – оценка безопасности методов химиотерапии и изучение объективного эффекта применяемых схем и режимов химиотаргетной терапии.

Вторичные конечные точки – изучение безрецидивной и общей выживаемости больных с первичной формой НХЛ ЖКТ IV A и B стадий.

Критерий включения: критериями включения будут служить пациенты (взрослые до 80 лет) и дети с 5 до 15 лет с НХЛ ЖКТ IV A и B стадиями заболевания и различной степени злокачественности.

Критерии исключения:

1. возраст свыше 80 лет;
2. застойная сердечная недостаточность, нестабильная стенокардия, нарушение ритма и проводимости, острый инфаркт миокарда;
3. почечная недостаточность (уровень сывороточного креатинина более 0.2 ммоль/л); печеночная недостаточность, острый гепатит (уровень сывороточного билирубина более 1.5 норм, АЛТ, АСТ более 3х норм, ПТИ менее 70%);
4. тяжелая пневмония (дыхательная недостаточность, одышка более 30 ДД в минуту, артериальная гипоксемия менее 80 mmHg);
5. Сепсис (септикопиемические очаги, нестабильная гемодинамика);
6. Угрожающие жизни кровотечения;
7. Тяжелые психические нарушения (бред, тяжелый депрессивный синдром и другие проявления продуктивной симптоматики);
8. Физическая несостоятельность, требующая постоянного ухода, кахексия (уровень общего белка ниже 35 г/л);
9. Декомпенсированный сахарный диабет (сахар крови выше 15 ммоль/л);
10. Беременность.

Оценка первичных конечных точек (в основных и контрольных группах) включает проведение больному ОАК, биохимического анализа крови, биопсия опухоли с последующим гистологическим, цитогенетическим и ИГХ исследованиям, таковые проводятся всем пациентам до лечения. При верификации НХЛ с экспрессией CD 20(+) антигена больному назначается ПХТ, включающая ритуксимаб (6-8 курсов). Установление стадий заболевания, рентгенологическое исследование органов грудной

клетки, УЗ томография периферических и забрюшинных лимфоузлов, КТ органов брюшной полости и средостения, ЯМРТ и ПЭТ по показаниям скинтиграфия скелета.

Результаты лечения больных и их обсуждение

Результаты лечения детей с первичной неходжкинской лимфомы кишечника III-IVA и V стадий.

В детском отделении КазНИИОиР лечение получали 6 детей с неходжкинской лимфомой толстого кишечника, IV B стадий. У 3-х больных зарегистрирована НХЛ илеоцекального угла толстого кишечника.

Пример: Больной М. 13 лет, клинический диагноз: НХЛ илеоцекального угла толстого кишечника, ст. IV B, состояние после дезинвагинации кишечника, резекция илеоцекального угла, тонко-толстокишечный анастомоз конец в конец. Заключение ИГХ исследования: НХЛ, CD 20 (+). Больной получил 6 курсов ПХТ по схеме R-CHOP21. По данным МРТ и КТ ОГК и ОБП достигнута полная ремиссия процесса, рецидив процесса не зарегистрирован в течение 5 лет. Больной находится под наблюдением онкологов ООД.

Двое больных получали Мабтеру с диагнозом мелкоклеточная лимфома толстого кишечника, ст. IV B, состояние после резекции толстого кишечника, ИГХ заключение: мелкоклеточная лимфома CD 20 (+), больной проведена ПХТ по схеме R-CHOP21 (7 курсов), у одного ребенка достигнута полная ремиссия процесса, у одного – частичная. Рецидив процесса не зарегистрирован в течение 5 лет.

Шестая пациентка Х. 11 лет, наблюдается с диагнозом: лимфома Беркитта илеоцекального угла, ст. IVB, состояние после гемиколэктомии. Гистологическое и ИГХ заключение: лимфома Беркитта. Больной проведен 7 курсов ПХТ по схеме R-CHOP21, также достигнута полная ремиссия процесса. У 1 ребенка с рефрактерной формой НХЛ III B стадий после 4-х курса ПХТ по схеме CHOP зарегистрирован рецидив заболевания, которым было проведено 6 курсов ПХТ по схеме R-CHOP21+ трансплантация аутологичной ГСК и достигнута полная ремиссия процесса. Рецидив заболевания не зарегистрирован в течение 5 лет.

Таким образом, предварительные результаты применения режима R-CHOP21 у детей с рефрактерной формой НХЛ показывает эффективность применяемого режима и его достаточную перспективность применения Ритуксимаба в лечении первичной неходжкинских лимфом желудочно-кишечного тракта у детей.

Применение режима R-CHOEP 21 у больных с первичной НХЛ желудочно-кишечного тракта III - IV A и B стадий.

Проводилось лечение 10 больных с первичной НХЛ ЖКТ III-IV A и B стадий заболевания, из них у 6 пациентов была зарегистрирована MALT лимфома высокой степени злокачественности (диффузная крупноклеточная НХЛ), а у 4-х - MALT лимфома с низкой степени агрессивности.

По данным ИГХ у всех больных в опухоли установлена экспрессия CD 20, CD 30 CD43 антигена. Кроме того, установлена высокая пролиферативная активность опухолевых клеток, Ki 67 в 60,0% случаях варьировал от 40,0 до 80,0%, а в 40,0% - от 80,0 до 100,0%.

Установлено, что основным видом лечения лимфом ЖКТ является хирургический метод. Практически все

пациенты поступают в хирургические клиники с диагнозом рак желудка или толстого кишечника и диагноз НХЛ подтверждает только после гистологического и ИГХ исследования. Во всех случаях была выполнена тотальная резекция желудка и лимфодиссекция D2, в случае толстого кишечника – гемирезекция с лимфодиссекцией D2. Далее всем пациентам проводилось 6-8 курсов адьювантной ПХТ с применением

R-СНОЕР 21 (ритуксимаб по 350 мг/м², циклофосфамид 750 мг/м², доксорубин 50 мг/м², винкристин 1,4 мг/м², этопозид 100 мг/м² 1-3 дни, преднизалон 60 мг в/а 1-5 дни).

У 6 пациентов с НХЛ ЖКТ высокой степени злокачественности после 6-8 курсов ПХТ была достигнута положительная динамика. Общая пятилетняя выживаемость составила 80,0%. У 4-х больных с MALT-лимфомой низкой степени злокачественности применение режима R-СНОЕР 21 позволило достичь полной ремиссии у всех больных, а пятилетняя выживаемость составила 90,0%.

По данным Aviles A. [11] в проспективном рандомизированном исследовании изучали результаты лечения больных с ДКЖЛ желудка с применением одной ПХТ или хирургического лечения с адьювантной ПХТ и пришли к выводу о том, что нет достаточных оснований для включения в схему лечения резекции желудка. Проведение ПХТ, включающий таргетную терапию при первичной НХЛ ЖКТ позволяет достигнуть полную ремиссию у 85-100% пациентов [6]. Аналогичные результаты были получены, которые показали результаты консервативного лечения высоко агрессивных лимфом желудка с применением 6-8 курсов СНОР или 4-6 курсов ПХТ+локальная лучевая терапии, оказалось эффективной у 90% больных и позволило достичь 10-летней БРВ в 82% случаев.

В немецком многоцентровом исследовании по результатам лечения локализованных первичных лимфом желудка были собраны результаты лечения 747 пациентов, из которых 393 получали лучевую терапию и/или ПХТ или только хирургическое лечение [15]. Выживаемость в 42 мес. для больных, перенесших операцию составила 86%, по сравнению с 91%, получавших консервативное

лечение.

По данным Bartlett, David L. и соавт.[12] из 106 больных первичной диффузной лимфомой желудка низкой степени злокачественности у 34 на первом этапе была проведена резекция желудка и регионарных л/узлов, а у остальных проводилась только химиотерапия. 10-летняя актуальная выживаемость всех больных без признаков заболевания составила 91% для стадии I и 82% - для стадии II. Следуя полученными нами данными можно утвердить, что комбинированное лечение (ПХТ+хирургическое) дает лучшие результаты лечения. По данным [14] представили данные о лечении 130 больных первичными агрессивными В-клеточными лимфомами желудка. При этом после хирургического лечения трехлетняя БРВ составила 78%, после комбинации хирургическое лечение с ПХТ – 84%. Трехлетняя общая выживаемость (ОВ) и безрецидивная выживаемость (БРВ) при проведении только ПХТ и химиолучевой терапии составили 95,2 и 91,8%, соответственно.

Таким образом, в результате полученных нами результатов и обсуждения литературных данных можно сделать заключение о том, что режим R-СНОР после хирургического лечения является наиболее оптимальным. Однако следует отметить, что выбор комбинированного или комплексного методов лечения НХЛ желудочно-кишечного тракта должен зависеть от степени злокачественности и ее клинического течения.

Выводы:

1. Применение хирургического метода лечения и химиотаргетной терапии при НХЛ тонкого и толстого кишечника у детей оказалось наиболее эффективной, где пятилетняя выживаемость составила 100%.
2. При агрессивной форме НХЛ желудочно-кишечного тракта более эффективным является режим R-СНОЕР, где общая пятилетняя выживаемость составила 90,0%.
3. Доказано преимущество ПХТ после хирургического лечения при НХЛ желудочно-кишечного тракта, перед комбинированной терапией (хирургическое лечение+лучевая терапия).

Список литературы

1. Богданов А.Н., Максимов А.Г., Саржевский В.А., Аносов Н.А. Особые формы неходжкинских лимфом // Практическая онкология.-2004.-Т.5, №3.-С.217-221.
2. Грачева А.В. Роль лучевой терапии в комбинированном лечении больных экстра nodальными неходжкинскими лимфомами.... Автореф. дис. канд. мед. наук.-С-Пб., 2013.-25с.
3. Гранов А.М., Ильин Н.В. В кн. «Лимфомы». - С-П, 2010.
4. Давыдов М.И., Аксель Е.М. Злокачественные новообразования в России и странах СНГ в 2000 г.- М.: РАМН РОНЦ им. Н.Н.Блохина,- 2002.
5. Ильин Н.В., Виноградова Ю.Н., Николаева Е.Н. и др. Первичные экстра nodальные алимфомы//В.кн. «Лимфомы». Научно-прак.издание. Под общей ред. акад. РАМН Гранова и проф. Н.В.Ильина.-С-Пб.2010.-С.171-215.
6. Лорие Ю.Ю. Лимфомы из клеток мантийной зоны //Онкогематология.-2006.- Т.8, №1.-С.1-6.
7. Коксадзе Н.В. MALT-лимфома желудка: морфоиммунологические основы диагноза на материале гастробиопсии.... Автореф. дис. канд. мед. наук.- М., 2005.-25с.
8. Колесник Е.А. Злокачественные лимфомы пищеварительного тракта //Онкология.-2003.-Т.5, №1.-С.63-68.
9. Нургазиев К.Ш., Сейтказина Г.Д., Махатова Г.Т. Показатели онкослужбы Республики Казахстан за 2011 год.- Алматы, 2012.
10. Поддубная И.В., Неред С.Н., Суанова З.А. и др. Неходжкинские лимфомы кишечника-первичное экстра nodальное поражение //Современная онкология.-2010.-С.80-84.
11. Aviles A. Nambo M.J., Neri N. et. all. The role of surgery in primary gastric lymphoma: results of a controlled clinical trial // Annals of Surgery.-2004.-Vol.240, N1.-P.44-50.
12. Bartlett David, L.M.D. Long-term Follow-Up After Curative Surgery for Early Gastric Lymphoma //Annals of Surgery.-1996.-

Vol.233.-P.53-62.

13. Freeman C. Occurrence and prognosis of extranodal lymphomas //Cancer.-1972.-N.29.-P.252-260.

14. Kang Y.K.,Chang H.M. Comparison of surgery+chemotherapy+radiation with chemotherapy+radiation for localized aggressive B-cells primary gastric lymphomas //Seoul:The 28th Annual Meeting of the Korean Cancer Ass.-2002.-P.127.

15. Koch P., Probst A.,Berdel W.E. etall. Treatment result in localized primary gastric lymphoma: data of patients registered within the German multicenter study //J. Clin.Oncol.-2005.-N.23.-P.7050-7059.

16. Raderer M. Chemotherapy for management of localised high-grade gastric B-cell lymphoma //Ann Oncol.- 2002.-Vol.13.-P.1094-1098.

17. Reinartz G., Koch P.,Berdel W.E. etall. Radioth.Gastrointest.Non-Hodgkins Lymphoma //// Gastrointest. Oncol.-2012.- Vol.3, N3.-P.209-225.

Тұжырым

Р.Қ.Қарақұлов, С.Т.Габбасова,
Г.А.Сағындықов, Б.А.Нәсіпов,
А.С.Жазылтаева, Б.М. Жұмадуллаев
Қазақтың онкология жән радиология
ғылыми-зерртеу институты

Summary

R.K. Karakulov, S.T. Gabbasova, G.A.
Sagyndikov, B.A. Nassipov, A.S. Jazylytayeva,
B.M. Zhumadullaev
Kazakh Research Institute of Oncology and
Radiology

Ритуксимабты балалардың ішек- қарынының біріншілік Ходжкин емес лимфомасын емдеуде қолдану

Rituximab in the treatment of the non-Hodgkin's Lymphoma of Gastrointestinal Tract

Жұмыста балалардың ішек-қарынының біріншілік Ходжкин емес лимфомасын емдеуде Ритуксимабтың әсері зерттелді. Балаларға аш және тоқ ішегіндегі ісікті алу отасы жасалып, содан кейін 6 дүркін R-CHOP кестесі бойынша химиялық ем жасалды. Аурулардың 5 жылыдық өмір сүруі уақыты 100% жетті.

Түйінді сөздер: Ритуксимаб, балалардың ішек-қарынының біріншілік Ходжкин емес лимфомасы, аурулардың 5 жыл өмір сүруі.

The results of treatment of 16 patients with NHL gastrointestinal tract III-IV A and B stage, 6 of them are children with NHL of the small and large intestines.

We used effective targeted drug - Rituximab for 6 children with NHL- B cell form of the gastrointestinal tract after bowel resection which was performed first.

All patients received 6 cycles of chemotherapy regime, five-year survival rate was 100%. In 10 adult patients with B cell NHL form GI was used scheme R-CHOP-21 and the overall five-year survival rate was 90%.

Keywords: NHL of gastro intestinal tract, B cell lymphoma, Rituximab, five year overall survival